导致全身炎症反应综合征(ARDS是其在肺部的表现)

可能可能最可能：**严重肺炎、重症胰腺炎**、严重烧伤、脓毒症、胃内容物吸入、大面积创伤、非心源性休克、溺水等病史，1 周内（多在原发病起病后 72 小时内发生）急性进行性呼吸困难，双肺浸润影，**一般吸氧后不好转（顽固性低氧血症）**

三、检查 血气分析:COPD并发肺性脑病、严重支气管哮喘、ARDS

1.首选**血气分析**：诊断 ARDS 的必要条件——**氧合指数 $PaO_2/FiO_2 \leq 300$**

①分度：**轻度 200-300、中度 100-200、重度≤100** 高浓度吸氧(FiO_2↑),但氧分压升高困难→PaO_2/FiO_2↓

②若患者吸入 40%浓度氧气（氧浓度=21+4×氧流量）、氧分压 80mmHg，则氧合指数为 80/0.4=200

2.鉴别心源性肺水肿：

①**心脏超声（首选）**

左心衰→肺淤血(PAWP>18mmHg)

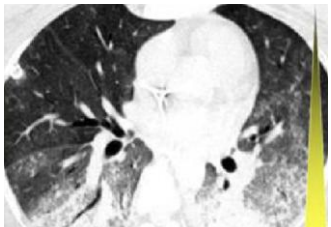
②Swan-Ganz 心导管测定肺小动脉楔压：**诊断 ARDS 时 PAWP＜18**；但 PAWP＞18 不能排除 ARDS

可合并左心衰

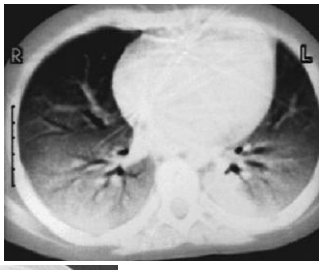
3.X 线→CT（主要在重力依赖区）：早期轻度间质改变，继之**非心源性肺水肿**，后期肺间质纤维化

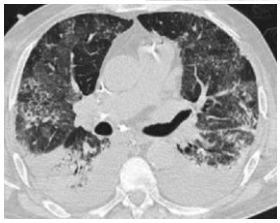


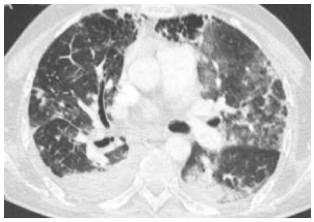
图 2-15-1 ARDS 病人的 X 线胸片显示两肺广泛斑片浸润影



炎性渗出集中在脊柱(重力依赖区)







四、治疗

1.**高**浓度吸氧：保证 $PaO_2 \geq 60$、$SaO_2 \geq 90\%$ 69

2.多数患者尽早**机械通气**

（1）压力控制通气较容量控制通气更常用　既要保证肺泡中有足够的气体,又不能因为气体过多加重肺泡损伤→必须保证压力控制在一定水平→压力控制通气更常用

（2）**呼气末正压 PEEP 最重要**

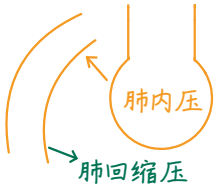
①适当水平的 PEEP：先 5cmH_2O→8-18cmH_2O 使萎陷的肺泡和 ttsx 小气道再开放（我爸是吧）

内源性PEEP:COPD和支哮由于气体呼不出去,留在肺泡里的气体增多→呼气末时肺泡是正压

②PEEP 的目的是改善氧合和肺顺应性：增加呼气末肺容量，使萎陷的肺泡和小气道再开放，改善弥散功能和通气/血流比例（减少肺内分流），防止肺泡随呼吸周期反复开闭反复开闭会再次损伤肺泡

③PEEP 的不良反应：

肺气压伤	因此要从低水平开始
使胸腔内压力↑→**回心血量↓**	因此血容量不足者应补充血容量



胸膜腔内压(胸内压)=肺内压+(-肺回缩压)